

Ruta clínica local de tendinopatía de aquiles

Ruta clínica | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Estandarizar evaluación de seguridad, objetivos y seguimiento sin sustituir juicio clínico ni presentar esta propuesta como GPC oficial.

2. Alcance y condiciones de uso

Ruta local centrada en tendinopatía de porción media; GPC JOSPT Revision 2024. No trasladar automáticamente su alcance a lesión insercional o rotura.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Confirmar identidad, motivo, antecedentes, evolución, demandas de actividad y objetivos

Confirmar identidad, motivo, antecedentes, evolución, demandas de actividad y objetivos. Revisar informes disponibles y mantener reserva de los datos; definir si el caso está dentro del alcance de la ruta.

2. Buscar alarmas: Dolor súbito con pérdida de función, sospecha de rotura o signos sistémico

Buscar alarmas: Dolor súbito con pérdida de función, sospecha de rotura o signos sistémicos requieren valoración antes de programa de carga; distinguir localización y evolución. Registrar evidencia y conducta, evitando completar casillas de un examen no realizado.

3. Realizar medidas funcionales y examen pertinentes con método y unidades

Realizar medidas funcionales y examen pertinentes con método y unidades. Distinguir dato observado, hipótesis y diagnóstico fisioterapéutico; utilizar instrumentos con versión y permisos comprobados.

4. Elaborar plan: Definir manejo de carga y ejercicio según capacidad y respuesta, sin dosifi

Elaborar plan: Definir manejo de carga y ejercicio según capacidad y respuesta, sin dosificación idéntica para todos. Medir función y tolerancia y adaptar progresión; revisar guía completa antes de adopción. Relacionar recursos, equipo, consentimiento, carga y vigilancia con la decisión y explicar alternativas.

5. Reevaluar novedades antes de cada sesión, documentar actividad real y respuesta y modifica

Reevaluar novedades antes de cada sesión, documentar actividad real y respuesta y modificar ante deterioro o falta de progreso. La disponibilidad de un equipo no constituye una indicación clínica.

6. Cerrar con comparación de línea base y resultados, objetivos pendientes, educación y conti

Cerrar con comparación de línea base y resultados, objetivos pendientes, educación y continuidad. Remitir cuando el riesgo o falta de respuesta lo exige; adoptar esta ruta después de lectura completa de la fuente y adaptación documentada.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Ruta propuesta hasta adopción documentada.

Revisar la fuente completa y nuevas recomendaciones.

Medir resultados funcionales con método consistente.

Auditar respuesta y razones de ajustes, no solo número de sesiones.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente y fecha	
Hipótesis y alcance	
Alarmas y conducta	
Medida inicial y método	
Objetivos	
Intervenciones y fundamento	
Dosis y respuesta	
Reevaluación	
Egreso o remisión	
Fuente adoptada y autor	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aquiles

Chimenti et al. Midportion Achilles Tendinopathy Revision 2024. JOSPT 54(12):CPG1-CPG32. DOI 10.2519/jospt.2024.0302. Alcance de porción media, no toda lesión del tendón.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39611662/>

Aprobó
Eliana Milena Pardo Ríos
TP 60576